



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN
KOMITE MUTU RS PRIMA HUSADA
MALANG
BULAN MARET TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Komite MUTU bulan Maret Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan berdasarkan tersedianya data, penggunaan data secara efektif dapat dilakukan secara *evidence-based* praktek klinik dan *evidence-based management*, berhubung sebagian besar rumah sakit mempunyai sumber daya terbatas, maka rumah sakit tidak dapat mengumpulkan data untuk semua hal yang diinginkan. Jadi rumah sakit memilih proses dan hasil *outcome* praktik klinik dan manajemen yang harus dinilai atau diukur dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan. Penilaian sering terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan rumah sakit memiliki peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dan keselamatan pasien membentuk budaya organisasi rumah sakit dan memberi dampak pada setiap aspek kegiatan berupa Standar Pelayanan Minimal dan pencapaiannya sesuai indikator yang dipergunakan di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada.

Dengan tersusunnya Laporan Komite MUTU bulan Maret tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit yang sesuai dengan STARKES. Berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikan indikator rumah sakit sebagai berikut: indikator mutu nasioanal (INM), Indikator mutu sasaran keselamatan pasien, Indikator mutu prioritas klinis rumah sakit, Indikator mutu tujuan strategis, indikator mutu perbaikan sistem, Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit).

B. Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.

Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada melalui pemantauan indikator mutu yang telah ditetapkan pada rapat kerja akhir tahun.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu spesifik lain yang dilakukan oleh tim/ komite/ unit terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas mengenai program mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada

BAB II

KEGIATAN PEMANTAUAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT TAHUN 2026

A. Kegiatan Pokok

Kegiatan pemantauan indikator mutu pada bulan Maret tahun 2026 yang dilaporkan pada Bulan April Tahun 2026.

B. Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/ unit
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

C. Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/ unit dilakukan setiap bulan, menyusun program perbaikan mutu oleh tim peningkatan mutu rumah sakit dilaporkan pada saat rapat bulanan.
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap tiga bulan.
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu

D. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh petugas pengumpul data unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab pengumpul data. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan ke kepala instalasi/unit, hasil ditulis pada Form Supervisi dilengkapi laporan tindak lanjut program untuk indikator yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan atau setiap ditemukan suatu permasalahan di setiap instalasi kerja dan ditembuskan Sub Komite Peningkatan Mutu.

BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan capaian indikator mutu nasional RS Prima Husada Malang pada bulan Maret tahun 2026.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Nasional RS Prima Husada Malang bulan Maret tahun 2026

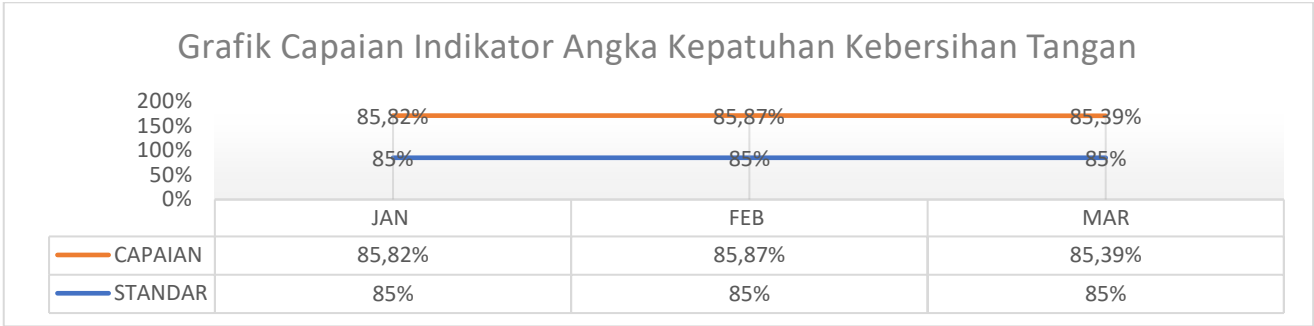
NO	Judul Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	85.82%	85.87%	85.39%										≥ 85%	85.69%	Ditingkatkan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96.82%	96.88%	96.40%										100%	96.70%	PDSA
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	99.96%	99.06%	99.89%										100%	99.64%	PDSA
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergens	100.00%	100.00%	100.00%										≥ 80%	100.00%	Dipertahankan

5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	89.90%	86.30%	89.20%										≥ 80%	88.47%	Dipertahankan
6.	Penundaan Operasi Elektif	0.00%	0.00%	0.00%										≤ 5%	0.00%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	66.75%	73.63%	68.35%										≥ 80%	69.58%	PDSA
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100.00%	100.00%	100.00%										100%	100.00%	Dipertahankan
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	86.13%	86.07%	86.45%										≥ 80%	86.22%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	30.51%	16.11%	18.75%										≥ 80%	21.79%	PDSA
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	91.54%	93.31%	95.60%										100%	93.48%	PDSA
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100.00%	100.00%	100.00%										≥ 80%	100.00%	Dipertahankan

13.	Kepuasan Pasien	99.70%	99.89%	99.79%										≥ 76,61	99.79%	Dipertahankan
-----	-----------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	---------------

3.1.1 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



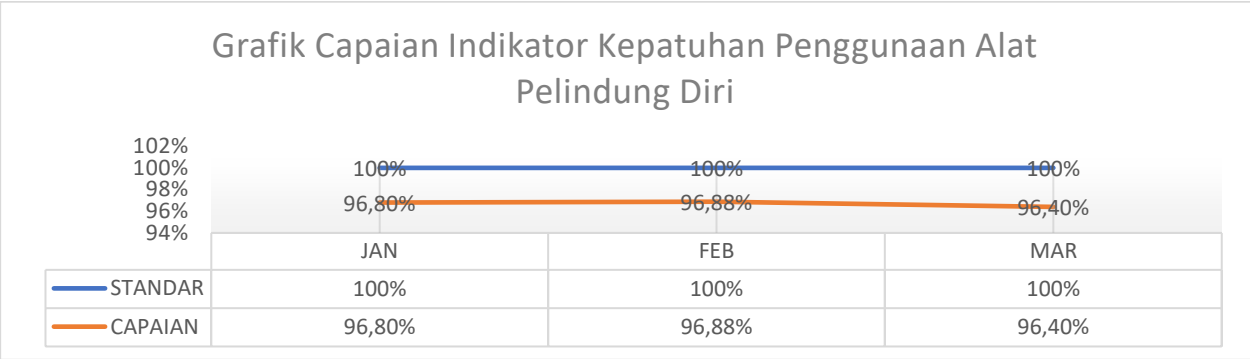
Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan RS Prima Husada Malang bulan Maret tahun 2026

Analisis:

Pada bulan Maret, angka kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Malang mencapai 85.39%. Berdasarkan grafik pada gambar 3.1, diketahui bahwa capaian ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0.48%. Meskipun capaian di bulan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan, namun berada sangat dekat dengan batas tersebut sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaiannya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat program edukasi, monitoring kepatuhan secara berkala, dan pemberian umpan balik kepada petugas. Sebuah studi Quality Improvement yang dilakukan oleh Sitohang dkk., (2025) membuktikan bahwa edukasi tenaga kesehatan, monitoring dan supervise IPCN, serta simulasi langsung *5 Moments Hand Hygiene* efektif dalam meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan di rumah sakit.

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Analisis:

Pada bulan maret, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di RS Prima Husada Malang mencapai 96.40% yang mengalami penurunan dari bulan Februari sebesar 0.48%. Capaian ini masih memiliki gap sebesar 3.60% dari standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Unit yang mencapai angka 100% dalam kepatuhan penggunaan APD terdiri dari IGD, HCU, ICU, PICU, IKO, IFRS, Pengadaan Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi. Sementara unit yang memiliki angka kepatuhan penggunaan APD terendah berada di IRNA 8A yaitu sebesar 75.83%.

Tabel 3.2 PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Maret tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan penggunaan APD di RS Prima Husada Malang pada bulan Maret 2026 sebesar 96.40% yang artinya masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Terdapat gap sebesar 3.60% yang dapat berisiko pada keselamatan petugas dan pasien. Masalah yang ditemukan adalah masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD baik yang tidak lengkap maupun berlebihan, pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata, kebiasaan kerja lama masih memengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten, dan monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan penggunaan APD sehingga mencapai standar minimal (100%) dengan mengingatkan petugas yang memakai APD berlebihan, mengevaluasi penggunaan stok APD, memberikan edukasi, dan melakukan supervisi terkait ketersediaan dan penggunaan APD.
Do	1. Pengawasan penggunaan APD 2. Edukasi penggunaan APD
Study	Capaian target bulan ini masih belum memenuhi standar minimal (100%) sebesar 96.40%. Terjadinya penurunan dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya.

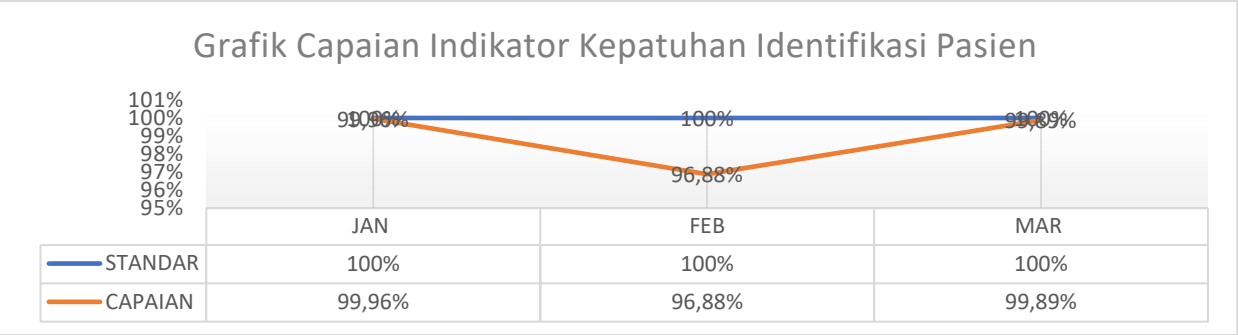
Action	1. Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. 2. Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. 3. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 4. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 5. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 6. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 7. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.
---------------	---

Tabel 3.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Seluruh tenaga kesehatan	Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi	• Komite PPI, IPCN	1 bulan
2	Peningkatan pemahaman staf terkait APD	Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	Perawat dan tenaga kesehatan	Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruangan	1-2 bulan
3	Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
4	Menurunkan kebiasaan penggunaan APD yang tidak sesuai	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Tenaga kesehatan di unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Kepala Ruangan • IPCN • Komite PMKP	Berkelanjutan
5	Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai 99.89% yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 3.01%. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan (100%) dengan gap sebesar 0.11%. Capaian sebesar 99.89% ini memang menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun adanya gap sebesar 0.11% berarti masih ada ketidakpatuhan dalam identifikasi pasien.

Tabel 3.4 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan Maret tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Maret sebesar 99.89%. Meskipun capaian ini sangat tinggi, namun masih ditemukan ketidakpatuhan dalam mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Beberapa petugas hanya mengidentifikasi pasien menggunakan nama saja, yang dapat berisiko terhadap keselamatan pasien.
Plan	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien di unit pelayanan, ditemukan bahwa kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah. Beberapa temuan antara lain petugas tidak melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir / nomor rekam medis) sebelum tindakan, pemberian obat, maupun pengambilan spesimen. Selain itu masih terdapat petugas yang tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta penguatan budaya keselamatan pasien.
Do	Komite PMKP bersama kepala unit dan ruangan melakukan sosialisasi kembali terkait standar identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan. Diingatkan mengenai pentingnya identifikasi pasien sebelum tindakan, pemberian obat, pengambilan sampel laboratorium,

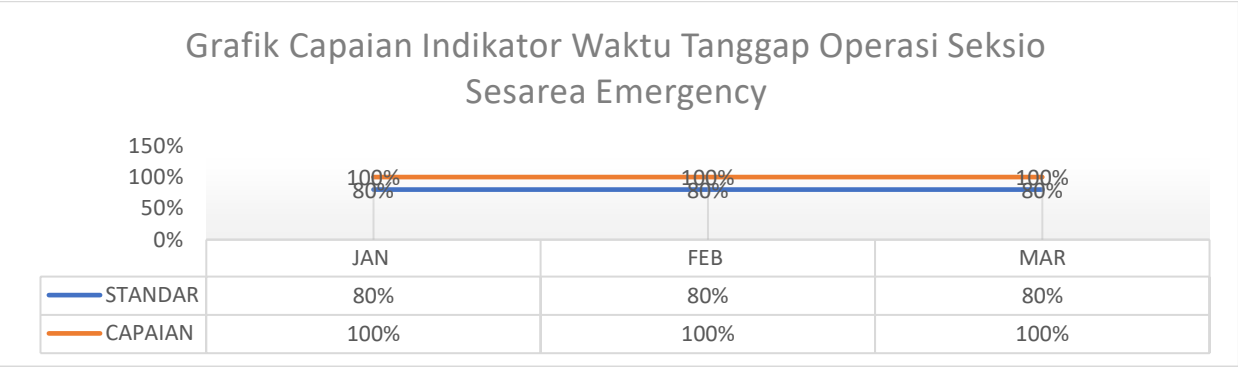
	maupun tindakan lainnya. Selain itu dilakukan monitoring dan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala serta pengawasan langsung oleh kepala unit.
Study	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi melalui audit kepatuhan identifikasi pasien pada periode monitoring berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien, namun masih ditemukan beberapa petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi terutama pada kondisi pelayanan yang sibuk atau pada pasien yang sudah dikenal oleh petugas.
Action	Peningkatan kepatuhan identifikasi pasien

Tabel 3.5 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.	Kepala ruangan	1 bulan

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

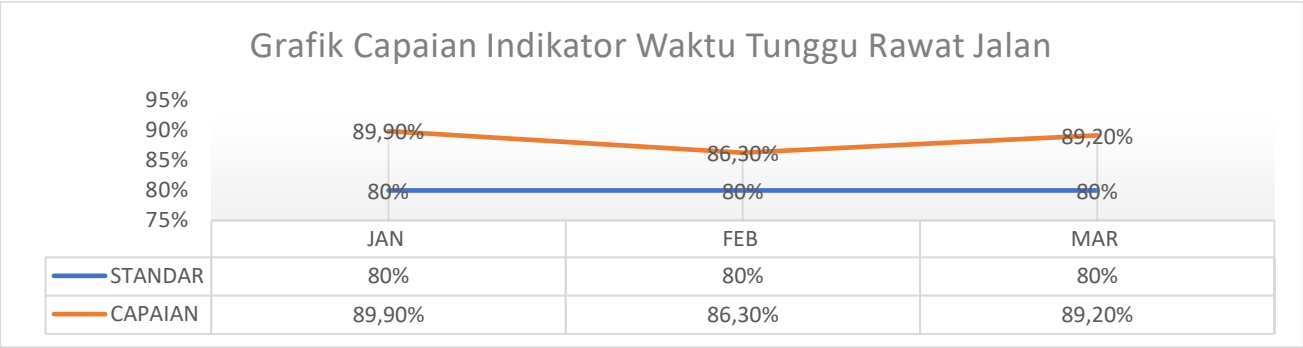


Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ≤30 menit mencapai 100%. Capaian tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan (80%). Dari 18 operasi seksio sesarea emergensi, semuanya telah mendapat respons ≤30 menit. hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergensi. Ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi faktor tercapainya indikator waktu tanggap operasi SC emergency. Hasil ini harus dipertahankan untuk meminimalisir risiko adanya komplikasi pada ibu dan bayi.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

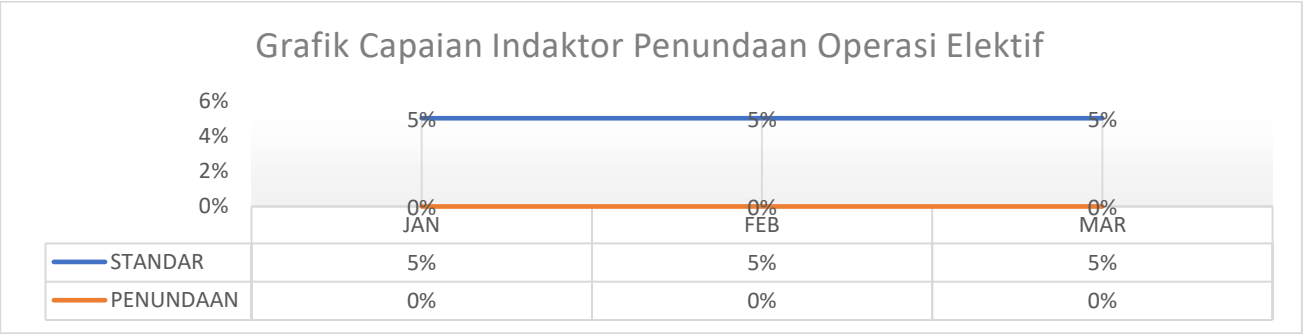
Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Analisis:
Pada bulan Maret tahun 2026, capaian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Malang mencapai 89.20%. Hasil ini telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan ($\geq 80\%$). Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.90%. Capaian belum maksimal 100% karena pendaftaran menumpuk pada jam jam tertentu dan masih ada keterlambatan kedatangan dokter. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah optimalisasi sistem antrean dan pendaftaran online dan penyesuaian jam praktik dokter.

6. Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

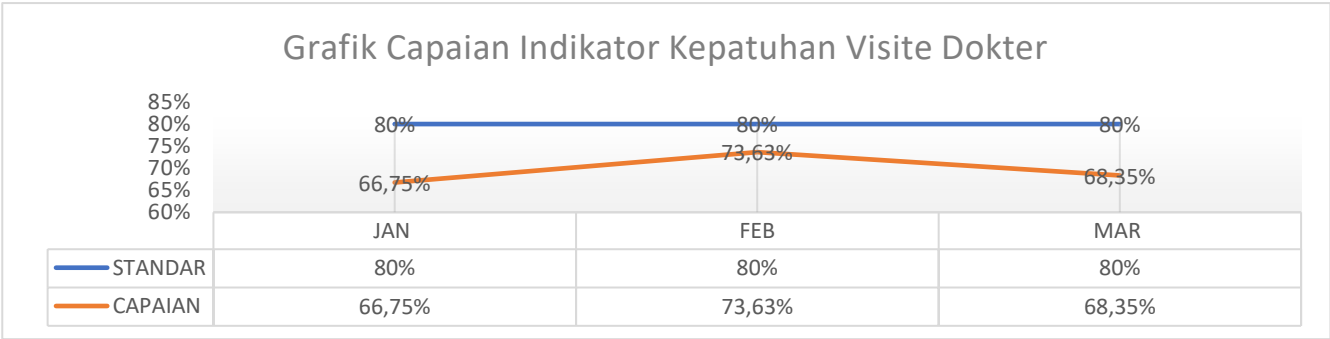


Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, indikator penundaan operasi elektif RS Prima Husada Malang mencapai 0%. Capaian ini telah memenuhi standar yang ditetapkan $\leq 5\%$. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif , perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, indikator kepatuhan waktu visite dokter RS Prima Husada Malang mencapai 68.35%. Hasil iini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 5.28%. Capaian ini juga tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan ($\geq 80\%$). Untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan, diperlukan upaya perbaikan.

Tabel 3.6 PDSA Capaian Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Problem	Capaian kepatuhan waktu visite dokter sebesar 68.35%, masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa dokter yang melakukan visite di atas jam 14.00. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan waktu visite dokter untuk memenuhi standar minimal ($\geq 80\%$) dengan penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.
Do	- Penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati - Koordinasi perawat dengan DPJP terkait jadwal visite - Monitoring pelaksanaan visite oleh manajemen/unit terkait
Study	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite dokter dapat diketahui bahwa capaian di bulan Maret yaitu 68.35%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang.
Action	Penguatan komunikasi dengan DPJP

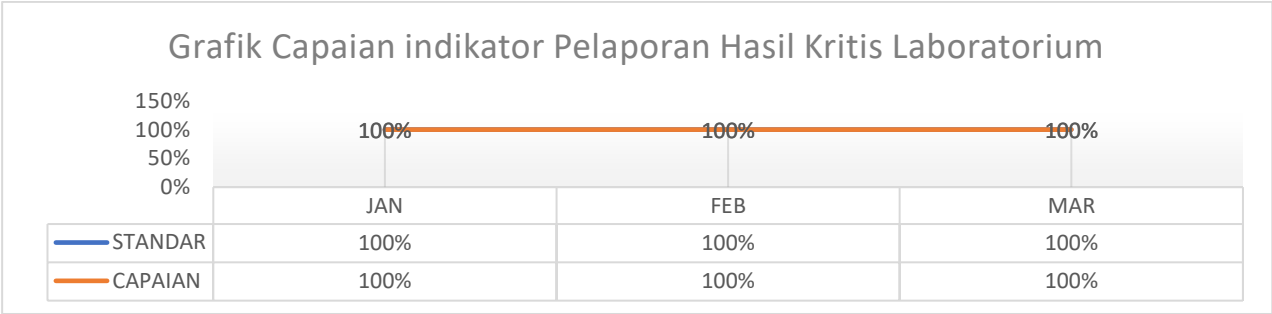
Tabel 3.7 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penguatan komunikasi dengan DPJP	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	DPJP yang tidak patuh waktu visite	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan waktu visite dokter secara berkala. Koordinasi dengan Komite Medik akan terus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan waktu visite. Selain itu, kepala ruang rawat inap diminta untuk melakukan pengingat dan pelaporan apabila	• Manajemen RS	1 bulan

				terdapat dokter yang belum melakukan visite sesuai waktu yang telah ditentukan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.		
--	--	--	--	--	--	--

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

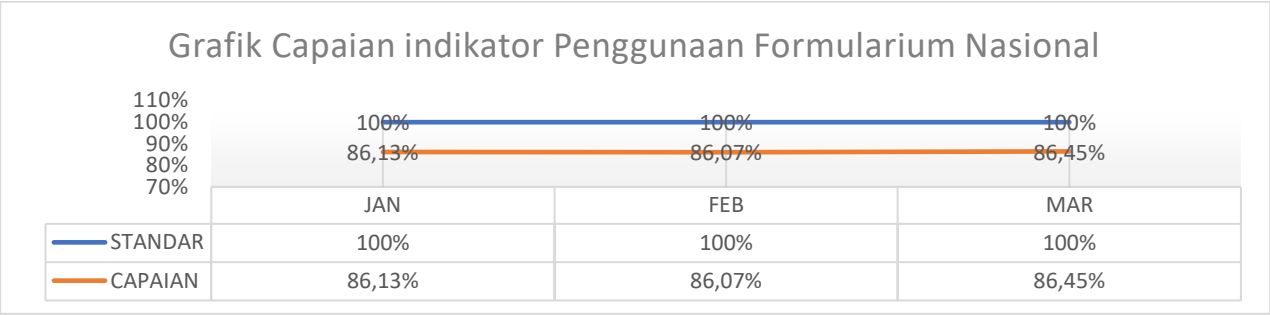


Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di RS Prima Husada Malang sebesar 100%. Hasil ini telah memenuhi standar yang ditetapkan (100%). Capaian ini berhasil dipertahankan selama 3 bulan berturut-turut. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu sosialisai kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis, penguatan alur komunikasi hasil kritis dan menjadikan pelaporan hasil kritis sebagai budaya keselamatan pasien.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium sebesar 86.45%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0.38%. Namun, meskipun mengalami peningkatan, capaian ini belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan (100%). Oleh karena itu, upaya perbaikan diperlukan agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Problem	Capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional sebesar 86.45%. Hasil ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yakni 100%. Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas), masih ditemukan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan daftar Formularium Nasional sehingga capaian indikator belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain masih kurangnya pemahaman dokter terhadap daftar obat dalam Formularium Nasional, belum optimalnya sosialisasi terkait pembaruan Fornas, serta belum adanya pengingat pada sistem peresepan apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Fornas.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional agar memenuhi standar yang ditetapkan dengan upaya perbaikan melalui sosialisasi penggunaan Formularium Nasional kepada tenaga medis, penyediaan daftar Fornas terbaru di setiap unit pelayanan, peningkatan peran instalasi farmasi dalam melakukan skrining resep, serta pelaksanaan audit resep secara berkala untuk memantau kepatuhan penggunaan Fornas.
Do	Upaya perbaikan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai Formularium Nasional. Selain itu instalasi farmasi mendistribusikan atau menyediakan daftar Formularium Nasional terbaru yang dapat diakses oleh tenaga medis di unit pelayanan. Petugas farmasi juga melakukan skrining terhadap resep yang masuk untuk memastikan

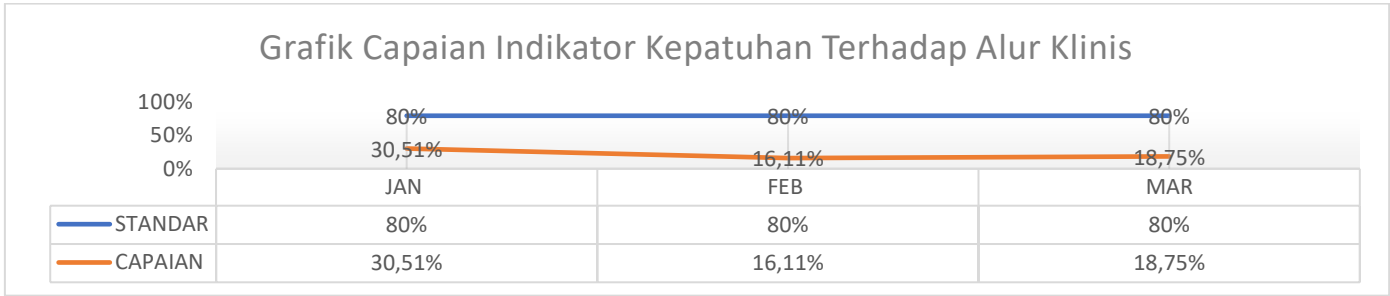
	kesesuaian obat dengan Formularium Nasional serta melakukan konfirmasi kepada dokter apabila ditemukan resep yang tidak sesuai. Tim PMKP bersama instalasi farmasi melakukan pengumpulan dan monitoring data penggunaan obat sesuai Fornas secara berkala.
Study	Berdasarkan grafik, diketahui bahwa capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Maret mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman dokter terhadap daftar obat dalam Formularium Nasional, belum optimalnya sosialisasi terkait pembaruan Fornas, serta belum adanya pengingat pada sistem peresepan apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Fornas.
Action	Sosialisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai Formularium Nasional

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi terkait pembaruan Fornas	Meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium nasional	Seluruh dokter dan tenaga kesehatan	Berdasarkan hasil evaluasi, apabila capaian indikator masih belum memenuhi standar maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sosialisasi ulang kepada tenaga medis, pembinaan kepada unit dengan tingkat kepatuhan rendah, serta penguatan proses skrining resep oleh instalasi farmasi. Selain itu rumah sakit juga dapat mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit dengan menambahkan fitur pengingat atau notifikasi apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Formularium Nasional. Monitoring dan evaluasi terhadap indikator ini akan terus dilakukan secara berkala dan	Manajemen RS	1 bulan

				hasilnya dilaporkan kepada Komite PMKP serta manajemen rumah sakit sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan		
--	--	--	--	---	--	--

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
 Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Analisis:
 Pada bulan Maret 2026, capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis (*clinical pathway*) RS Prima Husada Malang sebesar 18.75%. Hasil ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.64%. Namun, meski mengalami peningkatan, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 61.25%. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diupayakan perbaikannya agar semakin mengecilkan gap dengan standar setiap bulannya.

Tabel 3.9 PDSA Kepatuhan terhadap Alur Klinis

Problem	Capaian kepatuhan alur klinis pada bulan Maret sebesar 18.75%, mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.64%. Namun, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan (80%). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga medis belum sepenuhnya patuh dalam menggunakan atau mengisi dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan. Beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman petugas mengenai penggunaan alur klinis, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, serta kurangnya monitoring dari unit terkait.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap alur klinis agar memenuhi standar yang ditetapkan (80%) dengan sosialisasi kembali mengenai penggunaan alur klinis, peningkatan monitoring kepatuhan pengisian oleh kepala ruangan atau PJ Mutu Unit, serta koordinasi dengan Komite Medik dan DPJP.

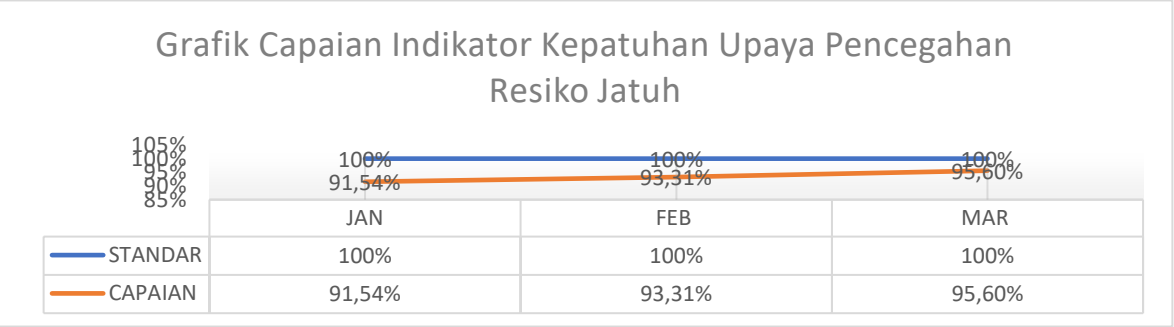
Do	Tim PMKP bersama Komite Medik melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan alur klinis dalam pelayanan pasien. Selain itu dilakukan pengingat kepada DPJP dan petugas terkait untuk mengisi alur klinis sesuai diagnosis yang telah ditentukan. Kepala unit rawat inap juga diminta melakukan monitoring kelengkapan pengisian alur klinis pada rekam medis pasien.
Study	Capaian kepatuhan terhadap alur klinis pada bulan Maret sebesar 18.75%. Sementara pada bulan Februari mencapai 16.11% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2.64%. Hal tersebut karena tenaga medis belum sepenuhnya patuh dalam menggunakan atau mengisi dokumen alur klinis (clinical pathway) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan.
Action	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (clinical pathway)

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>)	Meningkatkan kepatuhan pengisian dokumen alur klinis	Seluruh tenaga medis pelayanan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite PMKP akan melakukan penguatan implementasi clinical pathway kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai standar yang ditetapkan.	Manajemen RS	1 bulan

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 95.60%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.29%. Meskipun capaian ini mengalami peningkatan namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 4.40%. Perlu upaya perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan Maret sebesar 95.60%. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun masih di bawah standar 100%. Terdapat gap sebesar 4.40% yang berisiko pada keselamatan pasien. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh agar memenuhi standar 100% dengan sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Do	- Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala - Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) - Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko - Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh

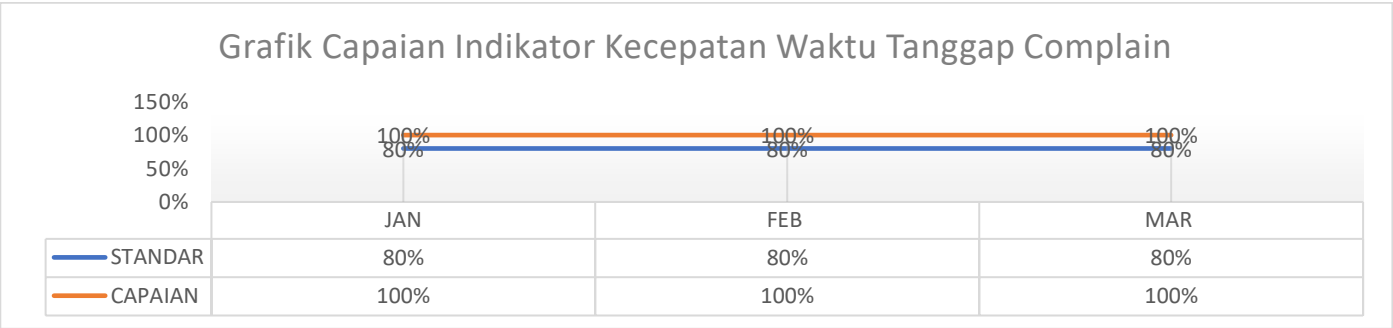
Study	Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Maret sebesar 95.60%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Action	Sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan angka kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh	Meningkatkan pemahaman staf tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Seluruh tenaga kesehatan	Sosialisasi ulang standar pencegahan risiko jatuh	Komite Keperawatan	1 bulan
2	Audit kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	Kepala Ruangan	1-2 bulan

12. Kecepatan waktu tanggap complain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain

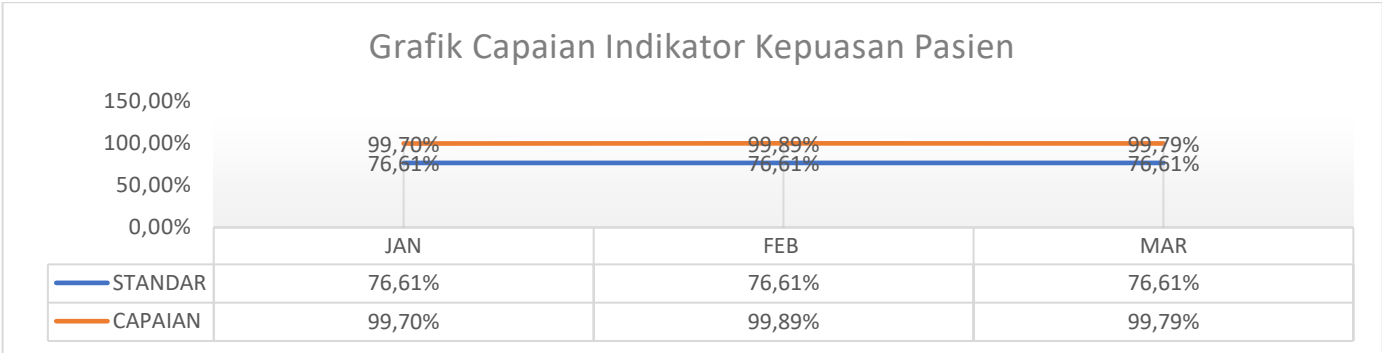


Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain sebesar 100%. Hasil ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan (100%) dan berhasil mempertahankan capaiannya selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui telfon, WhatsApp dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

13. Kepuasan Pasien

Gambar 13. Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator kepuasan pasien sebesar 99.79%. Capaian ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0.10%. Namun, angka ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 76.61%.

3.2 Pemantauan Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

Tabel 3. Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	-	92.14%	92.90%										100%	92.52%	PDSA
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	85.05%	85.70%	85.91%										100%	85.55%	PDSA

6.	Kepatuhan pemasangan handrell dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	-	87.11%	92.08%										100%	89.60%	PDSA
----	--	---	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	------

3.3 Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)		7.08%	12.50%										100%	9.79%	PDSA
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)		12.1%	21.48%										100%	16.79%	PDSA
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)		8.31%	12.05%										100%	10.18%	PDSA

3.4 Tujuan Strategis

NO	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	5	1	3										0	3	PDSA

3.5 Perbaikan Sistem

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	10.38%	17.34%	16.84%										100%	14.85%	PDSA

BAB IV
HASIL KEGIATAN MUTU PRIORITAS UNIT

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan												STAND ART
			Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agt '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	
1	Ketidaklengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI	IGD	-	54.72%	1.53%										0%
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	IGD	-	0	0										0
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	IGD	-	0	0										0
4	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	Rawat Inap	-	0	0										0
5	Angka Kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	Rawat Inap	-	55.64%	29.92%										0%
6	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	Rawat Inap	-	60.71%	56.75%										0%
7	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	ICU / HCU	-	70.45%	0%										0%
8	Kejadian Kesalahan saat hand over (serah terima)	ICU / HCU	0	0	0										0
9	Kejadian Keterlambatan pemasangan intubasi pasien	ICU / HCU	0	0	1										0

10	Angka pasien kembali ke perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam	ICU/HC U	0	4	0										<3%
11	Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek	Rawat Jalan	-	87.6%	84.62%										100%
12	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rrawat jalan	Rawat Jalan	-	2.55%	2.58%										0%
13	Target Pasien PRB dan iterasi	Rawat Jalan	-	-	1.14%										100%
14	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Rawat Jalan	-	0	0										0
15	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Fisiotera pi	5	2	0										0
16	Pelayanan tidak sesuai program terapi	Fisotera pi	0%	0%	0%										0%
17	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	Maternit as	11%	13%	15%										0%
18	Angka kematian ibu	Maternit as	0%	0%	0%										0%
19	Kejadian perdarahan post partum	Maternit as	3	3	2										0
20	Angka Kejadian partus macet	Maternit as	18.5%	31.3%	33.3%										<10%
21	Kejadian eklamsi	Maternit as	3	0	0										0

22	Kejadian pre eklamsi	Maternitas	0	1	1										0
23	Kejadian infeksi nifas	Maternitas	0	0	0										0
24	Angka Kematian Bayi	Neonatalogi	0%	0%	1.59%										0%
25	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	Neonatalogi	0	0	0										0
26	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	Neonatalogi	0	0	0										0
27	Kejadian re operasi	IKO	0	0	0										0
28	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	IKO	-	9.32%	1.49%										0
29	Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA	IKO	0	0	0										0
30	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	Laboratorium	0	24	27										0
31	Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi"	Laboratorium	100%	100%	100%										<3%
32	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah	Laboratorium	98.5%	100%	100%										100%
33	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	Radiologi	0	16	5										0

34	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	Radiologi	0	40	30									0
35	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	Instalasi Gizi	-	91.09%	87.76%									100%
36	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	Instalasi Gizi	-	100%	100%									100%
37	Angka Kelengkapan Pengkajian Gizi	Instalasi Gizi	100%	100%	100%									100%
38	Kejadian kesalahan pemberian diet	Instalasi Gizi	2	1	1									0
39	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	Instalasi Gizi	0	0	0									0
40	Kejadian makanan basi	Instalasi Gizi	1	1	0									0
41	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Farmasi	-	43.56%	43.06%									0%
42	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	Farmasi	0	0	0									0
43	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat	Farmasi	2	4	6									0
44	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	Farmasi	1	2	0									0
45	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat	Farmasi	1	0	0									0
46	Kejadian Kesalahan Input E-Resep	Farmasi	1	4	0									0

47	Keterlambatan sediaan farmasi datang	Pengada an Farmasi	-	20.6%	28%										0%
48	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	Pengada an Farmasi	-	0%	0%										0%
49	Angka selisih stok opname	Pengada an Farmasi	-	0.88%	0.73%										0%
50	Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam	Pengada an Farmasi	-	93.75%	97.37%										≥95%
51	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	PPI	0%	0%	0%										≤ 2 %
52	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	PPI	0%	0%	0%										≤3,5‰
53	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	PPI	0 ‰	0 ‰	1.82%										≤ 5,8 ‰
54	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	PPI	0 ‰	0 ‰	0.81%										≤ 4,7 ‰
55	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	PPI	0.35%	0.3%	0.17%										≤ 5 %
56	Angka Decubitus	PPI	0%	0%	9.09%										0%
57	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	PPI	0	0	0										0
58	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK	SDM	0%	4.72%	0										0

59	Angka turn over staf	SDM	1.4%	0%	0.28%										0%
60	Kesalahan pendaftaran pasien	Pendaftar an	-	25	25										0
61	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	Pendaftar an	-	4	1										0
62	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	Pendaftar an	-	0	1										0
63	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	K3RS	-	0	0										0
64	Waktu pengajuan klaim	Asuransi Center	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5										Tgl 5 awal bulan
65	Klaim pending RJTL	Asuransi Center	0	-	-										<0.1%
66	Klaim pending RITL	Asuransi Center	0	-	-										<1%
67	Klaim tidak layak	Asuransi Center	0	-	-										0%
68	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	Asuransi Center	0	-	-										<1 juta
69	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	Asuransi Center	0	-	-										<5 juta
70	Nilai selisih negatif klaim RJTL	Asuransi Center	251.175. 040	232.420. 655	151.929. 783										<50 juta
71	Nilai selisih negatif klaim RITL	Asuransi Center		-	-										<100 juta

			- 1.216.03 2.654												
72	Persentase readmisi pasien rawat inap	Asuransi Center	3.5%	1.8%	2.3%										0%
73	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	Asuransi Center	66.4%	58%	61.3%										100%
74	Angka keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x24 jam	IPSRs	93.15%	97.8%	97.24%										100%
75	Kejadian kerusakan sarana prasarana	IPSRs	124	156	145										0
76	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	Gudang Umum	4	8	1										0
77	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	Cleaning Service	90.91%	79.1%	84.62%										≥ 90%
78	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat)	Sekretariat	25%	0%	0%										0%
79	Kejadian linen ruang perawatan hilang	Laundry	0	16	38										0
80	Kejadian tercampur benda asing	Laundry	1	0	4										0
81	Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril	CSSD	2	0	0										0
82	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	CSSD	0	0	2										0
83	Kejadian CCTV tidak terecord	IT	0	0	2										0

84	Kejadian Komputer dan internet lemot	IT	60	53	17										0
85	Ketidakpatuhan pencatatan buku transit jenazah	Kamar Jenazah	0%	0%	0%										0%
86	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	Driver	0	4	1										0%
87	Kejadian Oncall driver	Driver	3	5	2										0
88	Penggunaan ambulance Luar RS	Driver	12	11	10										0
89	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	Security	1	0	1										0
90	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	Security	15	14	13										0
91	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	Kasir	2	5	5										0
92	Keterlambatan pelunasan pembayaran	Kasir	1	1	0										0
93	Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	Kasir	0	4	13										0
94	Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama	Humas	0	0	0										0
95	Kejadian komplain pasien karena keterlambatan pengantaran obat	Primanta ra	1	1	0										0
96	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	PKRS	-	-	87%										100%

97	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal	PKRS	-	-	93%										100%
98	Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi Oleh PPA	PKRS	-	-	90%										100%
99	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	PKRS	-	-	-										100%
100	Angka kepuasan pasien peserta BPJS	PIPP	99.89%	100%	100%										100%
101	Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%	100%										≥ 90%
102	Angka terhubungnya operasi dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%	100%										≥ 90%
103	Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis	PROGN AS TB	100%	100%	100%										100%
104	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	PROGN AS KB	25.6%	7.44%	10.6%										100%
105	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	PROGN AS KB	23.9%	9.9%	22.6%										70%
106	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	PROGN AS KB	92	94	89										0
107	Angka Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	PROGN AS STUNTING	-	-	-										100%

108	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)	PROGN AS STUNTI NG	-	-	-										100%
109	Angka pasien terkonfirmasi bakteriologis	PROGN AS TB	100%	100%	100%										
110	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS	PROGN AS HIV													100%

Laporan IKP Bulan Maret

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1.	1 Maret	Alfira	Instalasi Gizi	KTC	Kejadian makanan basi karena ahli gizi kurang teliti saat menginput update diet di komputer	Peningkatan kedisiplinan staf untuk membaca ulang secara keseluruhan dari daftar diet yang sudah di update dan fokus saat bekerja.
2.	1 Maret	dr. Akhmad Syahrir, Laras	Farmasi	KTC	Kesalahan input e-resep	- Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis - Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan medis dan kepala ruang poli untuk mengecek template resep agar dirubah dan tidak terjadi kesalahan berulang.
3.	2 Maret		Farmasi	KPC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
4.	10 Maret		IRNA 3C Anak	KPC	Tidak tertulisnya pengkajian alergi obat dari IGD sehingga tidak teroper ke ruangan	Refreshing di IGD mengenai input di e-rm mengenai alergi obat
5.	5 Februari	Elok, Bd. Deya	Maternitas	KTD	Pelaksanaan tindakan kristeller untuk membantu persalinan	- Audit maternitas - Pemahaman ada aturan dari dinkes tidak boleh kristeller - KIE tertulis dan ditandatangani kepada keluarga sebelum

						tindakan persalinan untuk semua pasien bersalin - Adfis DPJP tindakan kristeller untuk membantu persalinan - Inform consent jika dilakukan
--	--	--	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Komite Mutu rumah sakit di Rumah Sakit Prima Husada Malang Bulan Maret Tahun 2026. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dikerjakan saat ini, tentunya upaya yang berkesinambungan dan tidak mengenal lelah terus dilakukan sehingga tercapai hasil tertinggi bagi semua komponen pemberi dan pengguna layanan rumah sakit.

Malang, 10 April 2026

Ketua Komite MUTU



dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes